

إسم المريض ربيعاً : رانيا عثمان محمد اسماعيل
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : المطرية
رقم البطاقة : 27609301701701 رقم التليفون : 01093955308
العمر(تاريخ الميلاد) : 30-09-1976 المهنة : حاصل على دبلوم
العنوان : ++++++ تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 نفقات :
 ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: رانيا عثمان محمد اسماعيل
National ID: 27609301701701



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين



 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تعريف شخصية
 رانيا
 عثمان محمد اسماعيل
 قرية سفارة
 مركز البرشين - الجيزة
 ٢٠١٧.١٧.٣٠.٩٧٦
 JA4147469



 ٢٠٢٧/٠٩
 ٩٧٦.١٧.٣٠.١٧٠.١٧٠.١
 حصة على دهور صديق
 ابنى
 عثمان محمد اسماعيل
 قرية سفارة
 مركز البرشين - الجيزة
 ٢٠٢٧/٠٩/٣١





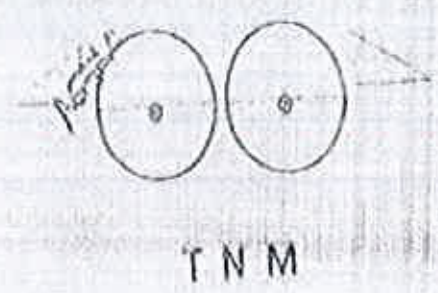

GA

MDT FORM
18/8/2022

First Name	أحمد محمد	MRSA	8/11/20
Last Name	أحمد	ID	1999000000
Medical Status	أحمد	Phone	011-2222222
MRSA	أحمد	Married Status	Single
Consent	أحمد	Family History	

CPRsed & A x 100% V entogut

Est	PR	HER2	HER2
2/18	5/18	u	65%
Sonoma Inova			
Post MACT			
Com Plan ALND			
Miss Working			



Recommendations
in - PCT, N: → ACK → Tard + cckp KKKKK.
→ PT ALN → 0/11

MDT OUTCOME & PLAN in view of PCR

for - PORT
- HLA (GR 2/18, PR 5/18 & lower).
Tamoxifen (24 → shift AL 34)

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE	RADIOLOGY	PATHOLOGY

Al-Saleh
0000000000

Name: **KANLA OTHMAN MOHAMED**

Date: **05.10.2021**

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS WITH CORONAL RECONSTRUCTION; -**

Chest:

- Few enlarged right axillary and sub pectoral pathological lymph nodes, the largest one measures about 4.4 x 3 cm.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. It shows tiny hypodense non enhancing focal lesion at left lobe segment III measuring about 4 mm.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Reviewing skeletal parts revealed no lytic or sclerotic osseous lesions.

OPINION:

- Few enlarged right axillary and sub pectoral pathological lymph nodes.
- No evidence of pulmonary nodules.
- Tiny non enhancing left hepatic lobe focal lesion likely of cystic nature.
- No evidence of lytic or sclerotic osseous lesions.

DR. Ibrahim Elsedawy, M.Sc, FEBR

Dr. Magmaa, md

Patient Name : **أورام دار السلام**
Patient No. : **27608301701701**
Path No. : **2028/22**
Sex : **Female**
Age : **45 Y**
Referring Doc :

Request No. : **13008490**
Request Date : **24/07/2022**
Verification Date : **10/08/2022**
Financial Category : **أورام دار السلام - متفرقة**
Department : **Out Patient**
Registered by : **All mostafa**

Pathology Report

CLINICAL DATA

Right pathological axillary lymph nodes with history of right breast ca. ca. post HACT.

NATURE OF SPECIMEN

Right axillary lymph node dissection.

GROSS PATHOLOGY

Fibrofatty tissue piece measured 9x9cm entangling 11 lymph nodes, the largest measured 2x2cm.

HISTOPATHOLOGY

revealed extensive nodal fibrosis in two lymph nodes, free of viable deposit (0/11) (effect of therapy).

DIAGNOSIS

Right pathological axillary lymph nodes with history of Right axillary lymph node dissection.

- Extensive nodal fibrosis in two lymph nodes, free of viable deposit (0/11) (effect of therapy).

- Stage : ypN0.

Signature
Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 10/08/2022 11:08:12

Page 1 of 1

Printing By : DR. Menna Nabil



National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل الباثولوجي المبادرة الوطنية لصحة المرأة

Pathology Report

Name: رانيا عثمان محمد اسماعيل Age: 44 years.
Clinical data: Rt axillary tail mass
Specimen type: tru cut biopsy
Date (Received): 7/8/2021. Date(reported): 14/8/2021
Lab. Number: 1692 / 21 Hospital Number:

Gross Examination:

- Procedure: tru cut biopsy
- Localization: Rt axillary tail mass
- Immunohistochemistry technique:

Microscopic examination:

- Histological type: metastatic IDC (GII)

Diagnosis:

Rt axillary tail mass mass, tru cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma GII
- Biomarkers:
 - ER: faint nuclear reaction in < 1% of tumor cells (Allred score 2/8)
 - PR: moderate nuclear reaction in 40% of tumor cells (Allred score 5/8)
 - Her2: negative membrane reaction in tumor cells (score 0)
 - Ki67: 65% nuclear reaction

Prof. Amal Hamed
Dr. Rana Fathy